Клинические рекомендации

Дистония

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G24** — Дистония **G24.0** — Дистония, вызванная лекарственными средствами **G24.1** — Идиопатическая семейная дистония **G24.2** — Идиопатическая несемейная дистония **G24.3** — Спастическая кривошея **G24.4** — Идиопатическая рото-лицевая дистония **G24.5** — Блефароспазм **G24.8** — Прочие дистонии **G24.9** — Дистония неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; Национальная ассоциация детских реабилитологов; Межрегиональная общественная организация «Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/867_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Клиническая диагностика 4

3.2 Дифференциальная диагностика 4

4. Лечение 5

4.1 Ботулинотерапия 5

4.2 Хирургическое лечение 5

4.3 Медицинская реабилитация 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Показания к госпитализации 5

6. Источник и актуальность **5**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Дистония — двигательное расстройство со стойкими или нерегулярными мышечными сокращениями, которые обусловливают патологические, как правило повторяющиеся, движения и/или позы. Обычно проявляется или усиливается при произвольных движениях.
- **Ларингеальная дистония**
  1. пограничная проблема между ларингологией (фониатрией) и неврологией;
  2. осиплость, прерывистый, сдавленный, «лающий» голос; шёпотная речь часто нормальная, при пении дисфонии может не быть;
  3. аддукторная форма — в 90% случаев, абдукторная — менее 10%;
  4. нарушение дыхания (прерывистое, сдавленное) иногда ошибочно расценивают как бронхиальную астму.
- Для дифференциальной диагностики ларингеальной дистонии с другими заболеваниями гортани предлагается фониатрическое и фониоскопическое исследование с визуализацией всех структур гортани.
- При спастической аддукторной дисфонии применяют #ботулинический токсин типа А: он снижает частоту прерывания голоса и тяжесть спазма. Инъекции вводят под электромиографическим и ларингоскопическим контролем; препараты могут вводить только специалисты со специальной подготовкой.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Дистония — двигательное расстройство, характеризующееся стойкими или нерегулярными мышечными сокращениями, обусловливающими появление патологических, как правило повторяющихся, движений и/или патологических поз.

Эти движения и позы нарушают определённые действия в вовлечённых областях тела. Дистонические движения, как правило, однотипны и имеют вращательный характер, могут проявляться тремором.

2.2 Этиология и эпидемиология

Причина может быть обусловлена врождёнными и наследственными факторами или быть следствием заболеваний нервной системы; наследование — аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное. В подавляющем большинстве случаев этиология остаётся невыясненной. Дистония занимает 3-е место среди двигательных расстройств.

2.3 Классификация

Формы по вовлечению областей тела

1. фокальная — одна область: блефароспазм, оромандибулярная, цервикальная, ларингеальная дистония, писчий спазм;
2. сегментарная — две и более смежные области (краниальная дистония);
3. мультифокальная — две и более несмежные области;
4. генерализованная — туловище и как минимум две другие области;
5. гемидистония — несколько областей с одной стороны.

2.4 Клиническая картина

Оромандибулярная дистония

1. непроизвольное открывание и/или закрывание рта, сжимание челюстей (дистонический тризм);
2. искривление губ, щёк, непроизвольные движения языка;
3. насильственная улыбка, особенно при речи и жевании;
4. корригирующие жесты: прикосновение к нижней половине лица, прикусывание губы, жевание предметов.

Начинается, как правило, в зрелом и пожилом возрасте; триггером может стать массивное стоматологическое лечение с протезированием.

Ларингеальная дистония — одно из наиболее тяжёлых нарушений голоса с напряжённо-сдавленной, прерывистой фонацией. Спазмы усиливаются при речевой нагрузке, эмоциональном напряжении, утомлении.

1. **аддукторная форма (90%)** — гиперактивность мышц-аддукторов голосовой щели: mm. cricothyroideus, cricoarytenoideus lateralis, interarytenoideus
2. **абдукторная форма (менее 10%)** — гиперактивность m. cricoarytenoideus posterior
3. **смешанные формы** — встречаются ещё реже

Характерно нарушение дыхания из-за нарушения прохождения воздуха через гортань; во время речи и пения дыхание обычно улучшается (парадоксальная кинезия).

Фарингеальная дистония проявляется затруднением глотания, чаще твёрдой пищи, и периодическим чувством «кома в горле» при глотании и/или в покое; часто сочетается с ларингеальной или оромандибулярной дистонией.

---

3. Диагностика

3.1 Клиническая диагностика

Дистонию диагностируют по особой неестественной (дистонической) позе, с тремором или без него.

Специфичные признаки

1. избыточные движения;
2. зеркальные движения;
3. корригирующие жесты.

Насильственные движения оценивают в покое и при нагрузке; оценивают и немоторные симптомы: боль, эмоциональные нарушения, расстройства сна.

Генетическое тестирование проводят только после клинической постановки диагноза.

3.2 Дифференциальная диагностика

1. **оромандибулярная дистония** — бруксизм, разные виды тризма, тики, миофасциальный синдром жевательных мышц с мышечно-суставной дисфункцией, поздняя нейролептическая и спонтанная орофациальная дискинезия
2. **ларингеальная дистония** — другие заболевания гортани — фониатрическое и фониоскопическое исследование с визуализацией всех структур гортани

4. Лечение

4.1 Ботулинотерапия

При спастической аддукторной дисфонии применяют #ботулинический токсин типа А и #ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс.

Цель

1. снижение частоты прерывания голоса;
2. снижение тяжести спазма;
3. увеличение периода фонаторного потока.

Диагноз в исследованиях устанавливала междисциплинарная группа: логопед, оториноларинголог, невролог.

Препарат вводили под электромиографическим и ларингоскопическим контролем; стандартные односторонние (50 ЕД) и двусторонние (по 25 ЕД с каждой стороны) инъекции в тироаритеноидные мышцы сравнивались у 50 пациентов.

Курсы инъекций повторяют **3–4 раза в год**; препараты ботулинического токсина вводят только специалисты со специальной подготовкой и опытом. После процедуры пациент **в течение часа** находится под наблюдением в лечебном учреждении для контроля немедленных аллергических реакций.

4.2 Хирургическое лечение

При генерализации дистонии и неэффективности лекарственного лечения проводится глубокая стимуляция мозга (у детей **с 7 лет**).

4.3 Медицинская реабилитация

Пациентам 18 лет и старше рекомендуется мультидисциплинарная программа реабилитации в стационаре: физическая терапия, кинезиотерапия, профессиональная переориентация, логопедические занятия, психотерапия.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация

1. хирургическое вмешательство: глубокая стимуляция мозга, микроваскулярная декомпрессия корешка VII пары при гемифациальном спазме;
2. ботулинотерапия при тяжёлых формах, требующих наблюдения в стационаре;
3. комбинированное лечение.

Экстренная госпитализация

1. осложнения дистонии;
2. осложнения лечения.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Дистония»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	867_1 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии; Ассоциация нейрохирургов России и др.
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В комментарии к рекомендации о ботулинотерапии спастической аддукторной дисфонии место введения названо «каждую щитоподъязычную мышцу», а далее в том же комментарии сравниваются инъекции в тироаритеноидные (щиточерпаловидные) мышцы — при аддукторной дисфонии препарат вводят в щиточерпаловидную мышцу.